

INFORME PSICOLÓGICO



Lic. Patricia Kucharsky R.
Especialista en Psicología Clínica - Terapias Breves – Enfoque Sistémico
Postgrado en Psicología y Psiquiatría Forense – Intervención y Prevención de Violencia y Políticas Públicas (ARG)

La suscrita Lic. Patricia Kucharsky, en calidad de Psicóloga Clínica y Forense con Matrícula profesional K-2 del Ministerio de Salud; eleva el siguiente informe:

1. DATOS GENERALES

Nombre y Apellido: David Osvaldo Penazzi Palacios
Documento de identidad: C.I. 5394304 SCZ
Lugar y fecha nacimiento: Santa Cruz; 17/06/64
Sexo: Masculino
Edad: 59 años
Ocupación: Jubilado

2. ANTECEDENTES FAMILIARES

El Sr. David Osvaldo Penazzi Palacios es separado, tiene 3 hijos de 31, 28, 26 y un bebé de 10 meses. Se encuentra en una etapa de adaptación a bastantes cambios, no refiere situaciones de estrés familiar significativo.

3. ANTECEDENTES CLÍNICOS

- Antecedentes de artritis reumatoide deformante.
- Dolores articulares intensos en rodillas, manos, codos y cadera.
- Dolores intensos en región cervical
- Astigmatismo y miopía
- Disminución de la audición
- Acidez estomacal y reflujo por las noches

4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA EL PSICODIAGNÓSTICO

- Entrevista Semiestructurada.
- Escala de Depresión de Beck.
- Escala de Ansiedad de Hamilton.
- Escala de Autoestima de Rosenberg.
- Test de Personalidad IPDE DSM-IV.

5. ACTITUD Y COMPORTAMIENTO DURANTE LA VALORACION PSICOLÓGICA Y EXAMEN MENTAL

Aspecto, vestimenta y aseo personal son adecuados, colabora durante la aplicación de las pruebas y responde adecuadamente a las indicaciones. Durante la entrevista muestra una conducta de levemente ansiosa. En cuanto el examen mental, se encuentra lúcido (consciente), bien orientado auto y alopsiquicamente, leve disminución de la memoria

INFORME PSICOLÓGICO



inmediata. Nivel de abstracción es acorde a su edad cronológica. No se aprecian alteraciones en el contenido y curso del pensamiento. Lenguaje espontáneo es coherente, lógico y detallado, presentando un juicio de realidad conservado. No se evidencia ninguna alteración sensorial (sin alucinaciones). No se evidencia de auto/ heteroagresividad.

6. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

6.1. ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA

"Trabajé 26 años en el rubro de la cervecera y me jubilé recientemente hace 2 meses, presento dolores por hernia discal cervical y la artritis reumatoide que cuando me deja muy mal, tengo adormecimiento de piernas y brazos. En marzo sentí un dolor intenso que me tumbó y bruscamente tuve que dejar de hacer algunas actividades como el ejercicio. Ya me acostumbré a convivir con un dolor constante pero tolerable, no puedo pasar mucho tiempo sentado o parado, tengo astigmatismo y miopía, la enfermedad es limitante y ya no puedo alzar peso, me he aislado un poco de mis amistades, no puedo hacer algunas actividades de familia como alzar a mi bebé."

"Mi vida cambió bastante después de la jubilación, pasé de tener un gran trabajo a pasar tiempo en el hogar y disminuir muchas actividades, pues afectó mis hábitos de vida y rutina, siento que estos cambios también disminuyeron un poco mi autoestima. Me siento más sensible, triste, tengo insomnio, falta de energía y desgano, bajé de peso, me cuesta expresar algunas emociones, tengo dolores de cabeza y cuando siento la ansiedad, me pongo tenso a nivel muscular, sensación de palpitación y opresión en el pecho. Tengo algunos problemas de memoria a corto plazo como pequeños olvidos, no quiero que mis problemas de salud empeoren y ser una carga para la familia."

"Me considero metódico, persistente, exigente con los demás y conmigo mismo, sociable, líder y con una mentalidad positiva"

6.2. ESCALA DE DEPRESIÓN (BDI) BECK: Instrumento utilizado para medir la severidad de una depresión. Consta de 21 preguntas con respuesta múltiple.

RANGO	PUNTUACIÓN	DIAGNÓSTICO
0-63	26	DEPRESIÓN MODERADA

Episodio depresivo caracterizado por tristeza asociada a las limitaciones de salud y asociada a adaptación a la etapa de jubilación laboral, disminución de la energía, apatía, insomnio, labilidad emocional disminución leve de la memoria y bajó de peso.

6.3. ESCALA DE ANSIEDAD DE HAMILTON: Es una escala clínica calificada, mide la severidad de la ansiedad basada en 14 ítems.

RANGO	PUNTUACIÓN	DIAGNÓSTICO
0-56	24	ANSIEDAD MODERADA

El evaluado presenta indicadores de ansiedad moderada caracterizada por preocupación por el futuro referido a las limitaciones que podría llegar a presentar por los problemas de salud, cefaleas, tensión muscular, sensación de palpitación y opresión en el pecho, angustia y fatiga.

Lic. Patricia Karparsky Ruiz
PSICÓLOGA CLÍNICA - FORENSE
Nat. Prof. K2

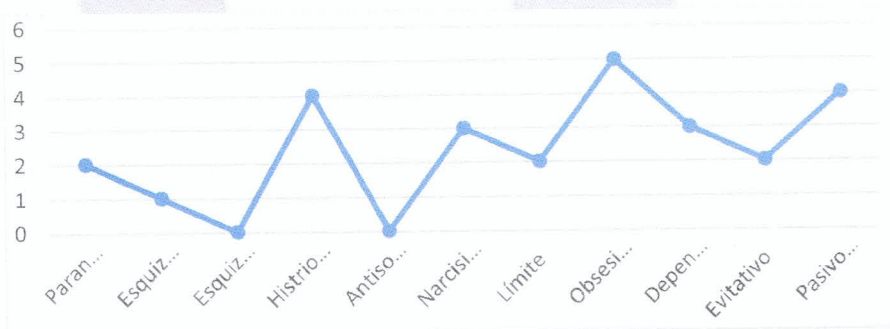
INFORME PSICOLÓGICO



6.4. ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSEMBERG: Escala utilizada para la medición global de la autoestima personal, incluye diez ítems cuyos contenidos se centran en los sentimientos de respeto y aceptación de sí mismo/a.

RANGO	PUNTUACIÓN	DIAGNÓSTICO
0-40	13	AUTOESTIMA BAJA

6.5. ESCALA DE PERSONALIDAD IPDE MODULO DSM-IV: Entrevista semiestructurada que evalúa los trastornos de la personalidad según los criterios de la DSM-IV.



El evaluado no presenta indicadores para trastorno de personalidad, sus rasgos son adaptativos y se caracteriza por presentar rasgos obsesivo compulsivo con tendencia a la eficiencia, responsabilidad, autoexigencia y exigencia a los demás. Rasgos histriónicos, sociabilidad y liderazgo, rasgos pasivo agresivos.

7. CONCLUSIONES

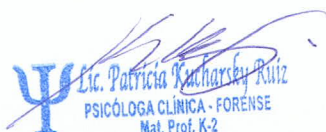
De acuerdo a la entrevista realizada, a los resultados de las pruebas psicológicas y criterios del CIE -10, el **SR. David Osvaldo Penazzi Palacios** presenta los siguientes diagnósticos:

F43.2 TRASTORNO DE ADAPTACIÓN CON PRESENCIA DE ANSIEDAD Y DEPRESIÓN (MODERADOS). Estado de malestar subjetivo acompañados de alteraciones emocionales que aparecen en el período de adaptación a un cambio biográfico significativo o a un acontecimiento vital estresante (enfermedad y jubilación). Esta alteración provoca un malestar significativo, baja en su autoestima, dificultades adaptativas que disminuyen la calidad de vida del paciente.

Es cuanto informo para fines consiguientes.

Las presentes conclusiones se sujetan al momento y contexto en el que se realizó la evaluación psicológica. Un cambio de las circunstancias o nuevos datos exigirían un nuevo análisis y podrían modificar los resultados.

Santa Cruz, 28 de mayo de 2024


Lic. Patricia Kucharsky Ruiz
PSICÓLOGA CLÍNICA - FORENSE
Mat. Prof. K-2